

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رجاء عاطف محمود محمد

المحافظة : القاهرة

الحي / المدينة : حلوان

العنوان : ممم

رقم البطاقة : 28408030103909 رقم التليفون : 01113826677

تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 03-08-1984 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة- الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضى الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالم
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رجاء عاطف محمود محمد National ID: 28408030103909	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

رجاء
عاطف محمود محمد
١ عرب الوالدة ش الزهور
حلوان - القاهرة

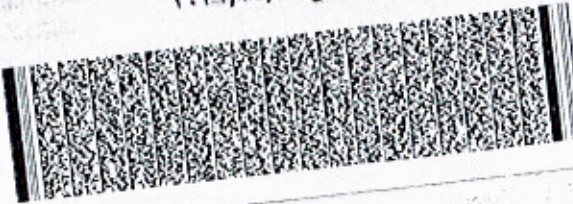


٢٨٤.٨.٣.١.٣٩.٩

KV9253279



٢٠٢٤/١١ ٢٨٤.٨.٣.١.٣٩.٩
حاصله على دبلوم معهد فنى
ادارة وسكرتارية
أنشئ
معلمة
رضا عبدالعزیز محمد بیومی
متزوجة
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١١/١٣





مجلس إدارة جامعة القاهرة
لجنة التعليم والبحث العلمي

சென்னை

301.3 / 2022

<u>Name</u>	Ms. Gable, J.	<u>MRN</u>	K9AA-C.C1
<u>Age</u>	37 yrs	<u>ID</u>	CASE-1111-1111
<u>Menopausal status</u>	pre-menopausal	<u>Phone</u>	111 111 1111
<u>OCP</u>		<u>marital status</u>	
<u>Co morbidity</u>		<u>Family history</u>	

<u>Bx:</u> IDC GI			
<u>ER:</u>	<u>ER:</u>	<u>HER 2:</u>	<u>Ki67:</u>
<u>Sonomammography:</u>			
<u>Mets Workup:</u>			
<u>Recommendations:</u>			

R

Post - of



Handwritten notes on the right side of the diagram:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

T N M

PT received NALT (FEC x3 → Tartrate x3) with partial response → Pt. SSIT discontinued on 10/3/2022

Pathology: 3 residuals $\leftarrow \begin{matrix} 2.5 \times 2c \\ 4 \times 3c \\ 1.7 \times 1.5c \end{matrix}$, GNB o/s

For: ① Port to Rt. CW (after total leech of the area of skin sloughing).
② Resume Tobidex & add AI (as per order for Sps) (+) probia q. 6-7hs.

MEDICAL ONCOLOGY

SI IRGEDV

SIGNATURE

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT FORM]]

Patient Name : الأستاذ / رجاء عاطف محمود محمد	Request No. : 13009858
Patient No. : 28408030103909	Request Date : 10/03/2022
Path No. : 677/2022	Verification Date : 19/03/2022
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 37 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer, multicentric, post chemotherapy.

Nature of the specimen:

Right nipple sparing mastectomy and SLNs biopsy. collected at 10/3/2022, 2.35 PM.

Gross Examination:

- Procedure: Right nipple sparing mastectomy specimen; measured 19x12.5x7 cm, covering skin ellipse measured 6x2 cm containing the base of the nipple
- Tumor extent
 - o Number: Two ill defined grayish white areas and an ill defined grayish white mass measured 2.5x2 cm and 4x3 cm and 1.7x1.5 cm, with least margin 1 cm
 - o Skin involvement: No
- Distance from margins: Away from deep margin by 2 cm.
- Lymph nodes number and size: Five nodules up to 0.7 cm
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: Free all SLNs (0/5)

Microscopic examination:

- Histological type: Residual invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II (3+2+1)
- Angioinvasion: Negative
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: Free all SLNs (0/5)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.
- Additional pathologic findings: No perineural invasion, no microcalcifications, free

Verified by :

walaa ghoniem

Patient Name	: الأستاذ / رجاء عاطف محمود محمد	Request No.	: 13009858
Patient No.	: 28408030103909	Request Date	: 10/03/2022
Path No.	: 677/2022	Verification Date	: 19/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار العمال
Age	: 37 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

submitted skin.

Diagnosis:

Right breast cancer; Right nipple sparing mastectomy and SLNs biopsy:

- Residual invasive duct carcinoma, grade II
- Pathologic partial response
- No DCIS component
- Free margins and submitted skin
- Free SLNs (0/5)
- ypT1 ypN0 ypMx

Prof.
Dr.

Verified by :
walaa ghoniem

Printing Date : 20/03/2022 10:22:40

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



MASSEY INSTITUTE

ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

مركز الأورام
وحدة الطب النووي

Patient Name: *Rogaa Atef Mahmoud.*

Date: *10/10/2021*

^{99m}Tc - ^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- Degenerative changes are noticed over dorso-lumbar vertebrae.
- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

The surveyed skeleton is free of any active osseous lesions.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Dr. Shorouk Mahdy, MD

Patient Name : الأستاذ / رجاء عاطف محمود محمد
Patient No. : 28408030103909
Path No. : 1987
Sex : Female
Age : 37 Y
Referring Doctor:

Request No. : 132369
Request Date : 06/09/2021
Verification Date : 16/09/2021
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
IHC No. :

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Lt breast two lesions.

Nature of the specimen:
tru cut biopsy of Lt breast mass

Gross Examination:
Two specimens were received:
) lesion at 8 O'clock: multiple gray white tissue cores up to 1.5 cm, totalt submitted
) lesion at 9 O'clock: multiple gray white tissue cores up to 1.5 cm, totalt submitted

Microscopic examination:
Sections examined of both specimens revealed breast tissue cores showed invasive malignant growth
formed of few groups and files of moderate atypical ductal epithelial cells surrounded by sclerotic
stroma.

Diagnosis:
breast lesions, tru cut biopsies:
specimens 1 & 2 :
invasive mammary carcinoma of terminal ductal lobular unit.

Biomarkers:
ER: Strong Intensity 90% nuclear reaction (Allred score 8/8)
PR: Strong Intensity 60% nuclear reaction (Allred score 7/8)
Her2: Negative membrane reaction (score 0)
Ki67: 10% nuclear reaction

Prof. Lubna Omar
Dr. Rana Fathy

Printing Date : 19/09/2021 10:06:45

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed youss

مركز البحوث الطبية - القاهرة
Room No. 401 - First Floor Building No. 401, El-Dokki, Cairo
11528

Name: Heudon Atef

Date: 26-9-2021

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

**** Referred case of breast cancer**

1. Chest:

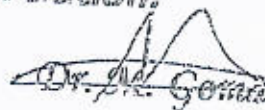
- Right upper lung lobe atelectatic bands are seen.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. Tiny hypodense focal lesion is seen at the hepatic dome (segment VIII) measuring 5 mm likely small cyst.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen in place.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Few dense sclerotic osseous lesions are seen at D5, L4 and sternal body, largest involving sternal body measuring 10 x 7 mm in maximal axial dimensions.
- D8 vertebral body two lytic lesions with vertical striations, in keeping with hemangiomata.

OPINION:

- *Hepatic dome (segment VIII) tiny solitary focal lesion likely small tiny cyst for follow up.*
- *No pulmonary metastatic deposits.*
- *D5, L4 and sternal body dense sclerotic osseous lesions more larger at latter level , likely bone islands rather than metastatic , for bone scan correlation.*


Dr. M. Gomaa, M.D.